

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אוהד טל
משה סולומון

פ/25/1742

הצעת חוק צוותי התערבות במשבר, התשפ"ג–2023

הגדרות

1. בחוק זה –

"הוועדה" – ועדת הבריאות של הכנסת ;

"מוקד חירום נפשי", "מוקד החירום" – מוקד החירום הנפשי כמשמעותו בסעיף 2 ;

"סיוע נפשי ראשוני" – סיוע נפשי ראשוני בזירת אירוע לאדם שנמצא במשבר נפשי ;

"פקודת הרופאים" – פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז–1976¹ ;

"צוות התערבות במשבר" – כמשמעותו בסעיף 4 ;

"רופא" – רופא מורשה כמשמעותו בפקודת הרופאים ;

"השר" – חבר הממשלה, שהממשלה הסמיכה אותו לבצע חוק זה בתוך 90 ימים מיום תחילתו של חוק זה, ואם לא הסמיכה כאמור – שר הבריאות.

הקמת מוקד חירום נפשי

2. (א)

השר יקים מוקד חירום טלפוני לסיוע נפשי ראשוני ; מוקד החירום ישמש למענה על פניות טלפוניות למתן סיוע נפשי ראשוני.

(ב) מוקד החירום יפעל ברציפות בכל ימות השנה ; הפעלת המוקד והזנקת צוותי התערבות במשבר לשם מתן טיפול נפשי ראשוני ייעשו בהתאם להוראות לפי חוק זה.

(ג) ההתקשרות למוקד החירום תיעשה בחיוב מקוצר ולא תחויב בתשלום.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 30, עמ' 594.

- פעילות המוקד 3. (א) את מוקד החירום יאיישו מוקדנים שיעברו הכשרה מקצועית ייעודית של 60 שעות לפחות, כפי שיקבע השר בתקנות (בחוק זה – מוקדנים).
- (ב) מוקד החירום יקבל פניות במקרים שמתעורר בהם צורך להעניק גם סיוע נפשי ראשוני מכל אלה:
- (1) אזרחים;
 - (2) מוקדי החירום של מגן דוד אדום, של המשטרה וגופי ביטחון רשמיים אחרים;
 - (3) מחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות.
- (ג) קיבל מוקד החירום פנייה המצריכה מתן סיוע נפשי ראשוני בזירת האירוע, ישלח המוקדן למקום האירוע שני חברים לפחות מצוות ההתערבות במשבר, בהתאם לשיקול דעתו ולפי טיב התלונה.
- (ד) לשם קבלת ההחלטה על שליחת צוות להתערבות במשבר למקום האירוע כאמור בסעיף קטן (ג) ועל הרכבו, יתייעץ המוקדן לפי הצורך בחבר צוות ההתערבות במשבר שישמש כתורן לעניין זה.
- (ה) המוקד ינהל רישום של פניות שהתקבלו והטיפול שניתן, ויקיים מעקב על פניות חוזרות של אותו אדם.
4. (א) השר יקים במסגרת משרדו צוות רב מקצועי להתערבות במשבר שייתן תמיכה וסיוע נפשי ראשוני, וחבריו יהיו:
- (1) רופא מומחה בתחום הפסיכיאטריה;
 - (2) פסיכולוג כהגדרתו בחוק הפסיכולוגים, התשל"ז–1977²;
 - (3) עובד סוציאלי כהגדרתו בחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו–1996³;
 - (4) אחות כמשמעותה לפי פקודת בריאות העם, 1940⁴, בעלת מומחיות בתחום בריאות הנפש;
 - (5) רופא מומחה בתחום הנרקולוגיה;
 - (6) שוטר כהגדרתו בפקודת המשטרה, התשל"א–1971⁵.

² ס"ח התשל"ז, עמ' 158.

³ ס"ח התשנ"ו, עמ' 152.

⁴ ע"ר מס' 1065, תוס' 1, עמ' (ע) 191, (א) 239.

⁵ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390.

- (ב) חברי צוות התערבות במשבר יעברו הכשרה כפי שיקבע השר בתקנות ויהיו בכוננות קריאה בכל שעות היממה.
- (ג) עובדי צוות ההתערבות במשבר יהיו עובדי המדינה ויחולו עליהם הוראות חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959.⁶
5. מתן סיוע נפשי ראשוני (א) צוות ההתערבות במשבר יעניק סיוע ראשוני נפשי בהתאם לצורכי האדם שבמצוקה ובמסגרתו יבצע את הפעולות הבאות:
- (1) הגעה פיזית למקום האירוע;
 - (2) ביצוע הערכה ואבחנה של מצבו הנפשי של האדם;
 - (3) מתן סיוע נפשי ראשוני, לפי הצורך;
 - (4) שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי כל דין, לפי הצורך.
- (ב) צוות ההתערבות במשבר יתעד לאחר כל טיפול באירוע את הסיוע שניתן וימליץ על המשך טיפול.
- (ג) צוות ההתערבות במשבר יעביר את המידע לגופים הרלוונטיים על פי מצבו של האדם או על פי דחיפות האירוע.
6. תקציב התקציב השנתי לביצועו של חוק זה ייקבע בחוק התקציב השנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.⁷
7. ביצוע ותקנות (א) השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור הוועדה, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.
- (ב) תקנות לפי סעיף 3 יותקנו בהתייעצות עם שר הרווחה והביטחון החברתי ובאישור הוועדה.
8. תיקון חוק מוקדי חירום בחוק מוקדי חירום, התשע"ו-2016,⁸ בתוספת, אחרי פרט 3 יבוא:
4. "צוות התערבות במשבר."
9. שמירת סמכויות אין בחוק זה כדי לגרוע מאחריותו או מסמכותו של כל גוף אחר לפי כל דין.

⁶ ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

⁷ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

⁸ ס"ח התשע"ו, עמ' 878.

דיווח לוועדה 10. בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה ועד ליום י"ב בטבת התשפ"ו (1 בינואר 2026), ידווח השר לוועדה, אחת לשלושה חודשים, על יישום הוראות חוק זה, ובכלל זה על מספר צוותי ההתערבות במשבר שהוקמו והפעלתם ועל ההיערכות להקמתם של צוותים נוספים; לאחר המועד האמור ידווח השר לוועדה, אחת לשנה, על יישום הוראות חוק זה.

דברי הסבר

משבר נפשי הינו מצב קיצון של סבל ומצוקה החורגים מהשגרה, בו מופר אצל אדם האיזון הפסיכולוגי, ומשאבי הנפש אינם עומדים לו. משבר נפשי יכול להיגרם עקב השפעתם של גורמים חיצוניים, סביבתיים ואישיותיים, ולהתמודדות עמו השלכות בכמה מישורים: רגשי, התנהגותי ופיזיולוגי, והוא בעל השפעה ממשית על תפקודו ומערך חייו של האדם.

במדינת ישראל כיום, מערך שירותי הטיפול במשברים נפשיים בקהילה לוקה בחסר גדול. עבור אדם המתמודד עם משבר נפשי אקוטי אין כל מענה – עבורו ועבור בני משפחתו. במצב שכזה, אין כביכול הצדקה לאשפוז פסיכיאטרי, שאינו מועיל ואף עלול להזיק עוד יותר. בעת משבר, כשהמתמודד מרצון מבקש להתאשפז, בשל העומסים הכבדים, השירות לא תמיד יסופק לו וללא סיוע כצפוי הדרך להידרדרות מהירה קצרה. בזמן משבר, כשהמתמודד אינו מוכן להתאשפז, פעמים רבות לא יינתן אישור לאשפוז על ידי הפסיכיאטר המחוזי, מאחר ולא מלווה לבקשה חוות דעת עדכנית מאיש מקצוע על מצבו של המתמודד. יתרה מכך, אין דרך להשיג חוות דעת כזו, ואין אישור לבדיקה כפויה מכיוון שהוא אינו מסכן את עצמו או אחרים. במצב מורכב שכזה לא נותר לסביבה, לבני המשפחה ולאדם עצמו אלא להזעיק את צוותי החירום הקיימים והם חסרי כלים והכשרה לתת את הסיוע הנדרש.

מצבים משבריים חמורים, שחלקם כאמור נגרמים לא פעם בשל היעדר טיפול ראוי בשלב מוקדם יותר, מחייבים לעתים אשפוז, אך בשל חומרתו, כוחניותו והתיוג החברתי שהוא נושא עמו, ראוי כי יהא זה אמצעי שיורי. גם היותו טראומתי ובעל פוטנציאל נזק אדיר עבור אדם שממילא מצוי במצוקה נפשית, מצדיק את הפיכתו למוצא אחרון ובאין ברירה.

זאת ועוד, שירותי מד"א במתכונתם הנוכחית, נעדרים אף הם את הכלים המקצועיים לסייע לכ-20,000 קריאות בשנה לצורכי התערבות על רקע נפשי של אזרחים במדינת ישראל. ההנחה הרווחת היא שהצורך האמיתי בשטח רחב בהרבה, שכן היעדר מענה ראוי עבור מתמודדי נפש וקרוביהם מביא רבים להימנע מפניה לגורם כלשהו, חרף המצוקה הקשה והצורך בסיוע, כך שהצורך בצוותי התערבות במשבר חריף עוד יותר.

בעת משבר או הידרדרות אין לאדם המצוי במשבר או לקרוביו גורם ייעודי לפנות ולהתריע על הצורך לקבלת סיוע חירום או מניעת החרפה. מצבים אלו מתרחשים לעיתים לאחר הפסקת טיפול תרופתי או אירוע טראומתי, ומאופיינים בהסתגרות בתוך עצמם, סירוב או חוסר יכולת להכיר במצבם, והתנגדות להצעת המשפחה להיעזר ברופא. לעתים הם מביעים מצוקה על ידי התנהגות הפוגעת בסביבה: שוברים רהיטים בבית, זורקים עצים, מנפצים צלחות וכדומה, ואחדים מביעים מצוקה על ידי התנהגות הפוגעת

בזולת כמו בני המשפחה ושכנים או פגיעה עצמית.

תמונת המצב כיום מעלה מספר בעיות חריפות בהתמודדות עם משברים נפשיים אישיים בישראל. המערך הטיפולי הקיים אינו זמין בכל שעות היום, הנתונים הקליניים מפוזרים בין גורמים שונים ומקשים על סיוע אפקטיבי, המערך הטיפולי אינו מעניק טיפול בסביבה המוכרת והביתית של המטופל (reaching out) אלא בבידוד מהקהילה, ואינו מספק מענה לאנשים שאינם מאובחנים ומאוגרי טיפול. כמו כן, במצב הדברים כיום ישנו בזבוז וחוסר יעילות ניכר בשימוש במשאבים ציבוריים, ובכלל זה העסקת יתר של המשטרה, מד"א, תיקי סרק במערכות התביעה ובתי המשפט, אשפוזים שיכולים היו להימנע ועוד.

בעקבות שורה של מקרים שבהם נהרגו אנשים עם מוגבלות על ידי המשטרה, הקים בחודש יוני 2020 נשיא המדינה את הוועדה הבין-משרדית לטיפול בהתמודדות כוחות האכיפה והביטחון מול אנשים עם מוגבלות. אחת ההמלצות הבולטות של הוועדה הייתה הקמת צוותי התערבות במשבר. צוותים רב-מקצועיים אשר יתערבו בקריאה או בתלונה הנוגעת לאנשים עם מוגבלות. צוותים אלו ייתנו מענה ראשוני נפשי לפונים, יתווכו במידת הצורך בין המטופלים לבין גורמי האכיפה, יסייעו בפנייה לפתרונות טיפוליים, ייעצו לגורמי האכיפה בעת תקריות עם אנשים עם מוגבלויות וכדומה. בכך, ניתן יהיה למגר את תופעת "הקרימינליזציה של בריאות הנפש", אשר פושה במדינות רבות בעולם ובכללן ישראל, שכביכול מעניקה "טיפול פלילי" לאנשים הנזקקים לסעד טיפולי נפשי. בביטוייה החמורים של התופעה היא אף יוצרת השלכות שליליות נוספות כגון הומלסיות, התדרדרות לפשע, שפיטה ומאסר.

מוצע להקים מערך של צוותי התערבות במשבר בפריסה ארצית אשר נועד להתערב ולתת מענה ראשוני ורך יותר במצבים של משבר נפשי ובכך למנוע את החמרתם והפיכת המצב לקיצוני. צוותי התערבות במשבר יפעלו ויוזנקו לאחר קריאה שתתקבל במוקד הארצי לסיוע נפשי – בין אם על ידי אזרחים שיפנו למוקד ובין אם על ידי כוחות הביטחון או מחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות. הפניה תיענה על ידי מוקדנים שיוכשרו לכך, וכאשר המוקדן יחליט שיש צורך בהתערבות במשבר, ובפרט באותם מקרים בהם מעורב אדם עם מוגבלות – פיזית או נפשית, הוא ישלח לאירוע את צוות ההתערבות במשבר או בעלי תפקידים מסוימים מתוך הצוות – בהתאם לאירוע להרגעת המצב והכללה של המצב המשברי. בכך, מהווים צוותי התערבות במשבר גורם מתערב, המתווך בין מי שנקלע למשבר לבין המערכות המטפלות, בקהילה או בבית החולים לצורך קבלת טיפול ההולם את מצבו הנוכחי של האדם. צוות ההתערבות במשבר יפעל למנוע הסלמה מסכנת חיים, או כזאת המנתבת לפתרונות לא רצויים כמו כפייה או קרימינליזציה.

הצוותים יתנהלו בגישה פרואקטיבית המונעת הידרדרות של המתמודד וסביבתו, יספקו מענה טיפולי רך במקום גישה של אכיפה פלילית כיום ורק במקרים חריגים – התערבות משפטית.

מוצע כי הרכב הצוות יהיה רב תחומי ומקצועי והוא יורכב מפסיכיאטר, פסיכולוג, עובד סוציאלי, אח עם הכשרה בתחום בריאות הנפש, נרקולוג ושוטר. בכך, יהיו צוותי ההתערבות הכתובת הראשית והבלעדית להתערבות במצבי משבר ובמצבי חירום, כאשר נדרשת התערבות בטווח זמן קצר, לעיתים בעקבות הידרדרות או באופן בהול בעקבות אירוע חריג. בסיום ההתערבות, הצוות יפיק דוח מפורט הכולל הכוונה להמשך הטיפול.

מדינות רבות בעולם הבינו את הבעייתיות במתן מענה לא מותאם לאנשים במצבי משבר נפשי ואת הנזקים שמענה כזה יוצר, ובחרו לתת לה מענה בהקמת "צוותי משבר" (crisis teams) הנותנים מענה למצבי משבר על רקע מחלת נפש, מתוך תפיסה של מניעת אשפוז וטיפול בקהילה עד כמה שניתן. אם יש צורך באשפוז, דואגים להקל על האדם במשבר ועל בני משפחתו, על ידי כך שממעטים להשתמש באמצעי כפייה או באמצעים שעשויים לגרום לטראומה.

צוותי התערבות במשבר פועלים בשורת מדינות בעולם, וזאת בהצלחה רבה. כך למשל, הציגה ועדת המשנה לוועדה הבין-משרדית מדינות שבהן פועלים צוותי התערבות במשבר או פיילוטס להפעלתם. בממפיס, טנסי לדוגמה, פועלים צוותי כאלו המבוססים על שיתוף פעולה בין המשטרה, הקהילה, שירותי הבריאות והסגוריה. בניו יורק, פועל "צוות משברי נייד", המספק שירותים פסיכיאטריים ניידים, לשם טיפול יעיל ומהיר באירועים מסוג זה. באוסטרליה פועלים צוותים דומים. באנגליה, הופעל פיילוט בנושא המהיר בין גורמים שונים בתחום, וכולל רכבים ייעודיים המופעלים על ידי המשטרה וגורמי בריאות הנפש, חדר בקרה מאויש בגורמים רפואיים מוסמכים וכן קו טלפון הפועל באופן תמידי ומתופעל גם הוא על ידי אחיות בתחום בריאות הנפש. באמסטרדם מונחים כוחות השיטור לפנות לקבלת סיוע מגופי בריאות הנפש במקרה הצורך, וכן מופעל אמבולנס פסיכיאטרי המסיע את המטופלים וצוותיהם בצורה בטוחה ויעילה. מחקרים שנערכו על פעילות צוותי המשבר באנגליה ובארצות הברית, הראו כי הם אכן מובילים להתמודדות יעילה ונבונה יותר עם אנשים עם מוגבלות.

לפיכך מוצע לעגן בחקיקה הקמה של מערך של צוות התערבות במשבר, אשר יהווה גוף ייעודי שמטרתו לסייע לצמצום הסבל והקושי שנוצרים אצל מתמודדי נפש עקב מגננוני ההתערבות הנוכחיים, ימנע הגעה למצבי חירום, ויעניק טיפול ראשוני ומיידי בקהילה. מערך של צוותי התערבות במשבר הפועל 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע, יחזק ויבסס את המענה בקהילה ולא בבתי החולים, יתרום למניעת אשפוזים ולמתן מענה למשבר בקהילה, יבטיח יחס אמפתי למטופל ומשפחתו ויעשה שימוש באמצעים של התערבות במשבר וכלים פסיכיאטריים ופסיכולוגיים שנמצאו כמועילים. נוסף על כך, מערך כאמור ימעית את השימוש באמצעי כפייה ויביא להימנעות משימוש בערוץ הפלילי, תוך התחשבות ברקע החברתי והתרבותי של האדם במשבר ושל בני משפחתו.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת מיכל וולדיגר (פ/3855/24 ; פ/5/25).

הצעת החוק זהה לפ/3855/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)